

Task 4: БАС(ok)

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії
Автори:

- 1. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)
- 2. Гнатюк Ірина Михайлівна — розробка завдання , введення в електронну систему (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:
Мета завдання: Оцінити вміння аналізувати нейровізуалізаційні дані
Обладнання:

- 1. Комп'ютер

Витратні матеріали:
Не потрібно
Брифінг

До вас звернувся пацієнт з двохрічною історією прогресування поєданого тетрапарезу та вираженого псевдобульбарного паралічу.

ok

Текст завдання

До лікаря звернувся 58-річний чоловік із поступовим наростанням м'язової слабкості впродовж останніх двох років. Спочатку він відчував незначну слабкість у ногах, яка поступово поширилася на руки. Останні кілька місяців у нього також спостерігаються труднощі з ковтанням, зміни голосу та неконтрольовані емоційні реакції (напади сміху та плачу). При неврологічному огляді виявлено спастичний тетрапарез з підвищеними сухожильними рефlekсами, патологічні рефlekси Бабінського, клонуси та виражений псевдобульбарний синдром.

- 1. Уточнити скарги, анамнез хвороби, анамнез життя.
- 2. Поставити попередній діагноз, призначити необхідний метод нейровізуалізації (вказати відділи).
- 3. Інтерпретувати результати нейровізуалізації.

ok

Conditionally displayed materials:

1. Підзавдання - тригер: №5 (-Вказати зміни на наданих зрізах МРТ головного мозку)
2. Підзавдання - тригер: №5 (-Вказати зміни на наданих зрізах МРТ головного мозку)
3. Підзавдання - тригер: №5 (-Вказати зміни на наданих зрізах МРТ головного мозку)

Чеклист

1. -Привітатися, представитися, запитати як може звертатися до пацієнта Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Ознайомитися з наявними даними, уточнити скарги у пацієнта Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. -Встановити синдромальний діагноз Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
4. -Обґрунтувати необхідність проведення нейровізуалізації Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

5. -Призначити МРТ головного та спинного мозку нативне Значення: 11%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
6. -Вказати зміни на наданих зрізах МРТ головного мозку Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
7. -Вказати які структури уражені, специфічні ознаки (келих вина) Значення: 20%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
8. -Вказати зміни на МРТ спинного мозку Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Вказати для яких захворювань характерні дані зміни Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. -Вказати подальшу тактику ведення пацієнта Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора

Добрий день, мене звати (ім'я), я лікар невропатолог. Як я можу до вас звертатись? Як ви себе почуваєте? Що вас турбує?	Добрий день, лікарю. Мене звати Василь. Мене турбують постійні труднощі з рухами, спочатку були слабкість у ногах, а тепер і в руках. Два роки тому це почалося, і з того часу тільки погіршується. Тепер ще й з ковтанням проблеми, голос змінився, іноді сміюсь або плачу без причини.
Я вас уважно вислухав. Давайте трохи уточнимо. Як давно ви помітили слабкість у ногах? Чи є ще якісь симптоми, що вас турбують?	Слабкість у ногах почалася два роки тому, але я думав, що це тимчасово. Потім вона поширилася і на руки. Останні місяці важко ковтати, голос став незрозумілим, а іноді починаю сміятися або плакати без причини.
Ваша слабкість, яку ви відчуваєте в ногах і руках, а також труднощі з ковтанням та зміни голосу, можуть вказувати на серйозне неврологічне захворювання. Крім того, я помітив спастичний тетрапарез, підвищені сухожильні рефлекс та патологічні рефлекс Бабинського, що вказує на порушення у верхньому мотонейроні. Також ви відчуваєте клони і неконтрольовані емоції, що є ознаками псевдобульбарного синдрому.	Це звучить страшно. Що мені треба робити?
Оскільки симптоми вказують на ураження ЦНС, я рекомендую провести додаткові дослідження. Вам слід пройти магнітно-резонансну томографію (МРТ) головного та спинного мозку. Це може дозволити нам побачити характерні зміни, які допоможуть встановити діагноз	Добре
Демонстрація МРТ головного та спинного мозку	
На мрт Головного : на послідовностях FLAIR, коронарні зрізи виявляють гіперінтенсивність кортикоспінальних трактів з обох боків (ознака «келиха вина»), атрофія моторної кори. На МРТ спинного мозку теж спостерігається гіперінтенсивність кортикоспінальних трактів.	Зрозуміло, то що це, поясніть мені

Хочу пояснити, що ваші симптоми та результати МРТ можуть вказувати на наявність серйозного неврологічного захворювання, зокрема, на хворобу мотонейрона, таку як бічний аміотрофічний склероз. Це захворювання характеризується прогресуючим ураженням мотонейронів, що може призводити до слабкості м'язів кінцівок, порушень функцій ковтання, мовлення та дихання. На підставі ваших результатів МРТ головного та спинного мозку, де виявлена гіперінтенсивність кортикоспінальних трактів, я рекомендую продовжити діагностичний пошук. Це включає в себе: 1. ЕНМГ 2. Проведення додаткових досліджень для уточнення діагнозу, таких як генетичні тести для виявлення мутацій, зокрема мутацій гена SOD1, що можуть вказувати на генетичну форму хвороби. 3. Оцінку функції легенів та дихання для моніторингу респіраторних ускладнень. 4. Лікування, яке може включати препарати для полегшення симптомів і підтримки функції мотонейронів, наприклад, рилузол. Важливо, щоб ви регулярно консультувалися з неврологом для моніторингу вашого стану та коригування лікування. Ми також можемо обговорити ваші конкретні симптоми та можливі варіанти терапії, спрямовані на покращення якості життя.	Дякую, я все зрозумів
---	------------------------------

ok